

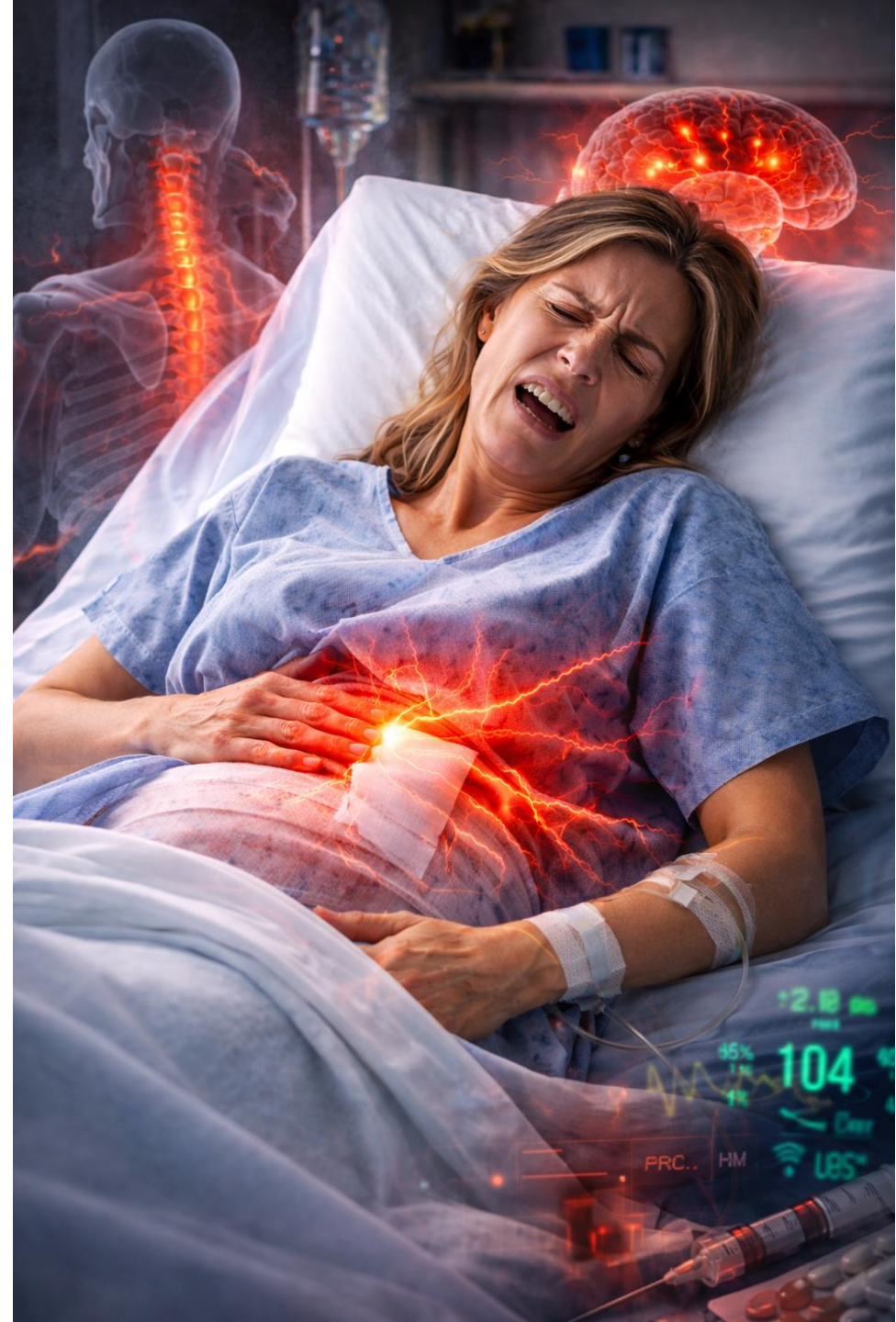
AMELİYAT ÖNCESİ VERİLEN EĞİTİMİN KAYGI VE AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİ

AĞRI YÖNETİMİ

Hemş. Esin İNEGÖL AYDOĞAN
Hemş. Gizem GÖKTAŞ
Uzm. Hemş. Hüseyin SAVAŞ
Uzm. Hemş. Ergin ÇAKIR



AĞRI



AĞRI

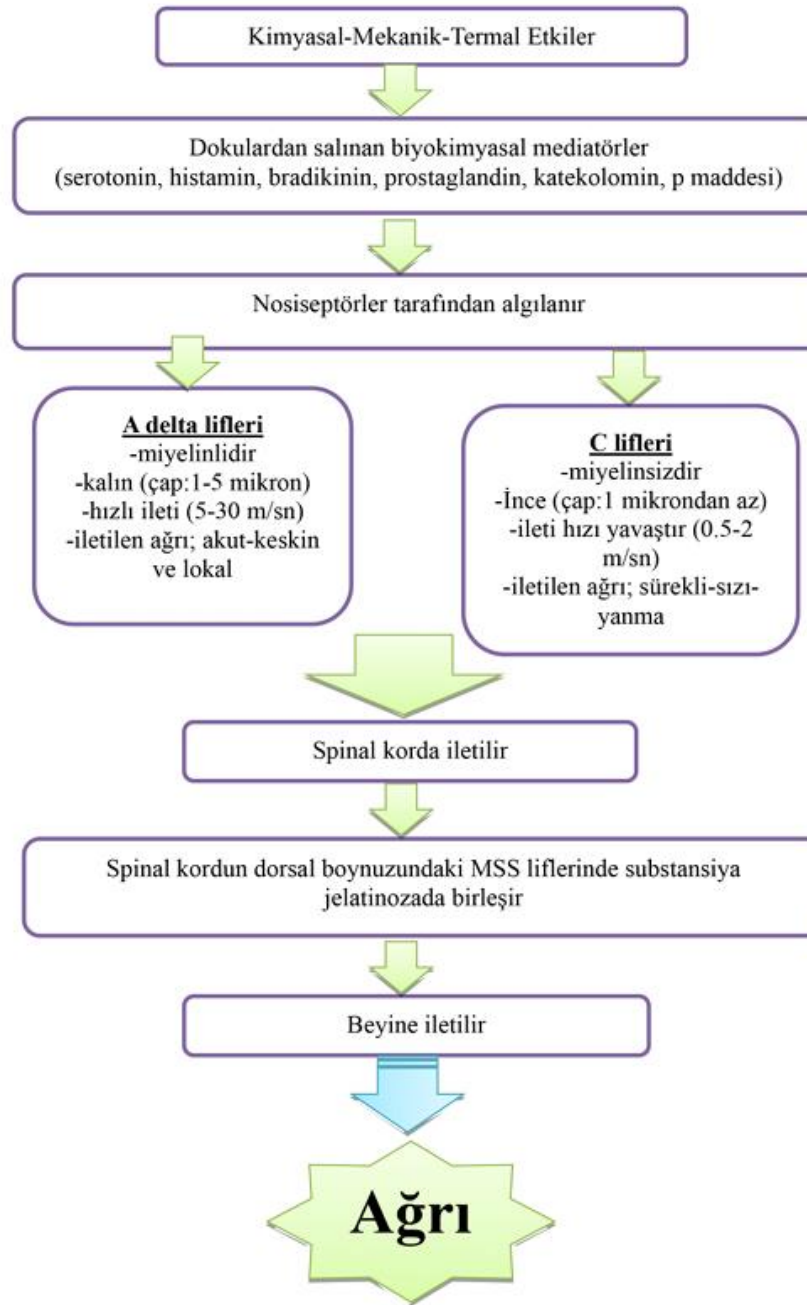
- Ağrı, gerçek veya potansiyel doku yaralanmasıyla ilişkili duyusal, duygusal ve davranışsal faktörleri içeren kişisel ve öznel bir deneyimdir.(Aslan Eti, F., & Arlı Karadağ, Ş. ,2017)
- Subjektif bir duygu olan ağrının en yaygın ve en çok kullanılan tanımlarından bir tanesini Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (International Association Study of Pain-IASP), var olan veya var olma olasılığı olan doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyim olarak tanımlamıştır. (International Association for the Study of Pain (IASP). , 29 Aralık 2023)

- Ağrının klinik bakımdan en yararlı tanımlanmasını McCaffery yapmıştır. McCaffery ağrıyı “bireyin söylediği şeydir, eğer birey söylüyorsa vardır” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkarak, hastanın ağrıyı ifade etmede en etkili kişinin kendisinin olduğunun belirtilmesi sözlü ya da sözsüz ağrı ifadelerine inanılması açısından çok önemlidir.
- Ağrının tanımı zordur. Milyonlarca insan geliştirilen ağrı giderme yöntemlerine rağmen akut ya da kronik ağrıyla baş etmektedir. Ağrı kaynağı ne olursa olsun bireyler hem fizyolojik hem de psikolojik olarak etkilenmektedirler. Amerikan Ağrı Birliği 1996 yılında ağrıyı beşinci yaşam bulgusu olarak ifade etmiş ve tedavi edilmesi gerektiğini belirtmiştir. (Özveren, H., Faydalı, S., & Gülnar, E. ,2018).

- Dünyada milyonlarca insan her yıl cerrahi operasyon geçirmekte ve ameliyatın sık görülen komplikasyonu olan ağrıyı deneyimlemektedir.
- Ağrı, hemşirelerin cerrahi birimlerdeki hastalarda en sık karşılaştıkları sorunlardan biridir ve birçok insan için en korkulan belirtiler arasında yer almakta, tedavi edilmezse birçok olumsuz durumla sonuçlanmaktadır.
- Ameliyat sonrası ağrı, ameliyattan hemen sonra yaşanır ve cerrahi işlem sırasında doku travmasına karşılık bir yanıt olarak tanımlanır. (Mahran, G. S., Leach, M. J., & Abbas, M. S. ,(2020)

- Giderilmeyen ağrı ise bireylerde bazı rahatsızlıklara sebep olarak yaşam kalitesinde düşme ile sonuçlanabilmektedir.
- Bu nedenle hemşirelerin ameliyat sonrası ağrı yönetimi hakkında doğru güncel bilgi ve becerilere sahip olması ve cerrahi birimlerde yatan hastalar için şefkatli bakım vermeleri oldukça önemlidir.(Adams, S. D. M., Varaei, S., & Jalalinia, F. ,2020)

- Postoperatif ağrı, ameliyattan hemen sonraki ağrıyı ifade eder ve haftalarca, aylarca devam edebilir.
- IASP, ameliyatı takip eden normal iyileşme süresinin yaklaşık 3 ay olduğunu ve bu süreden sonra herhangi bir ağrının patolojik olarak kabul edilmesi gerektiğini önermektedir.
- IASP tarafından “gerçek veya potansiyel doku hasarıyla ilişkili veya bu tür bir hasarla tanımlanan hoş olmayan bir duysal ve duygusal deneyim” olarak tanımlanan ağrı, doku hasarını önlemek veya sınırlamak için bir alarm gibi çalışan ve böylece önemli bir yaşamsal savunma işlevine hizmet eden fizyolojik bir rolü ima eder. (Fornasari, D. ,2014)



AMELİYAT ÖNCESİ VERİLEN EĞİTİMİN KAYGI VE AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİ

- Cerrahi hastalar için belirsizlik, en büyük anksiyete kaynağıdır. Yapılandırılmış bir eğitim; hastanın neyle karşılaşacağını bilmesini sağlayarak kontrol duygusunu artırır ve otonom sinir sistemi yanıtlarını stabilize eder. (Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi, 2018)



- Hasta birey, gerek hastalığın kendisinde oluşturduğu fiziksel etkiler gerekse hastaneye yatışın getirdiği çevre değişimi sonucu kaygı duymaktadır. Fiziksel ağrı veren işlemlerle karşılaşma, aileden uzak kalma, işini kaybetme, yabancı bir ortamda bulunma, bilinmeyen alet ve işlemlerle karşılaşma hastaneye yatan bireyin kaygı duymasına neden olabilecek etmenlerden bazılarıdır. Ameliyat olma da bu etmenlerin arasında bulunmakta ve önemli bir yer tutmaktadır. Anestezi, ameliyat ve bazı invaziv girişimler gerçek ve gerçek dışı korkulara sebep olur. (Yardakçı ve Akyolcu 2004, Elkin ve ark. 2004).

- Kaygının organizma üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır, bu etkilerinden biri ağrıdır.
- Ameliyat öncesi dönemde yaşanan kaygının yoğun olması, ameliyat sonrası dönemde yaşanan ağrının yoğunluğunu artırmakta ve kontrolünü zorlaştırmaktadır (Couma et al. 2001).
- Kaygı ve ağrı yönetimi; hastaların gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan planlı ameliyat öncesi bakım ve ekip hizmeti ile en aza indirilebilir. Ameliyat öncesi bakımın amacı, hastayı fiziksel ve ruhsal yönden ameliyata hazırlamaktır (Yardakçı ve Akyolcu 2004).

- Hasta ve aileye ameliyat süreci, bakım uygulamaları, ziyaret saatleri, fiziksel ortam hakkında bilgilendirme yapmak ise büyük bir öneme sahiptir. Perioperatif hemşirelik süreci ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemi kapsamakta olup, bu üç faz arasında kesintisiz bir geçişin sağlanması bakımın bütünlüğü açısından önemlidir. (ReviewMakale-Gevher Nesibe Medi Günlüğücal ,2025)



- Preoperatif eğitim, hastanın ameliyat öncesi dönemden taburculuğa kadar olan süreci anlamasını, beklenen sonuçlara uyum sağlamasını ve iyileşme sürecine aktif katılımını hedefleyen sistematik bir süreçtir. Hemşire, bu süreçte sadece bir uygulayıcı değil, aynı zamanda bir "vaka yöneticisi" ve "eğitimci" rolündedir. Bilişsel Yük Teorisi: Hastaya verilen bilginin yapılandırılmış olması, bilişsel yükü azaltarak kaygının yönetilmesini sağlar. (Bastable, S. B. ,2022)

- Klinik uygulamalara bakıldığında ise sürecin genellikle parçalı ve yalnızca belirli ortamlarda ve belirli aşamalarla sınırlı kaldığı görülmektedir. Hastalar ameliyat öncesi, ameliyat esnasındaki ve ameliyat sonrasındaki üç fazı farklı bağlamlarda yaşamakta ve bu durum gereksiz stres ve kaygının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. (ReviewMakale-Gevher Nesibe Medi Günlüğücal ,2025)

- Anksiyete düzeyinin yüksek oluşunun iyileşmeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Bununla birlikte çalışma sonuçları cerrahi anksiyetenin hastalarda kontrol kaybı, beden bütünlüğünün bozulması ya da ölüm korkusu gibi stres kaynaklı belirtileri ortaya çıkardığı görülmüştür. (Yakupoglu, S., & Kaya, H. ,2025).

- Kol. ve arkadaşlarının araştırmasında torakotomi operasyonu öncesi verilen ağrı kontrolü eğitiminin, hastalarda ameliyat sonrası ilk 48 saatteki hem ağrı düzeyini hem de analjeziklerin tüketimini azalttığı saptanmıştır. (Kol, E., Alpar Ecevit, Ş., & Erdoğan, A. ,2014)



- Hastanın ve yakınlarının, sorduğu sorulara anlaşılır şekilde yanıt vermenin yanı sıra; solunum, öksürme ya da pozisyon değiştirme gibi operasyon sonrası dönemde gerekli olan beceriler bu dönemdeki bilgilendirme konuları içerisinde yer almaktadır.
- Çocuk hastalarda ise psikolojik hazırlığın daha önemli olduğu dikkat çekmektedir. Bu noktada hemşire, çocuğun ve ailenin ameliyata dair bilgi sahibi olmasına yardımcı olarak anksiyete düzeyini azaltmakta ve operasyon sonrası ortama ve bakıma önceden hazırlanmasına destek olmaktadır. (ReviewMakale-Gevher Nesibe Medi Günlüğücal ,2025)

- Hastaya ameliyattan önce, operasyon sonrası orta ya da şiddetli düzeyde ağrı yaşanabileceğinin anlatılması önemlidir.
- Ağrıya neden olan faktörlerin (göğüs tüpleri, drenler, insizyon yeri ve boyutu vb), ağrıyı arttıran durumlar (operasyon sonrası hareket ve öksürme vb), ağrıyı azaltan farmakolojik (opioid ve nonopioid analjezikler) ve farmakolojik olmayan (insizyon yerinin desteklenmesi, pozisyon vb) yöntemler konularında eğitim verilmelidir.

- Bu eğitim, hastanın ağrı yönetimi ekibinin bir parçası olduğunu görmesi ve kendi ağrı kontrolünde aktif rol oynadığını bilmesi açısından önemlidir. (Erden, S., & Şenol Çelik, S. ,2013, Sakakura, N., Usami, N., Taniguchi, T., Kawaguchi, K., Okagawa, T., & Yokoyama, Y. 2010)



AĞRI YÖNETİMİ



- Ağrı yönetimi, ağrı mekanizmaları, sınıflandırılması, bireyselleştirilmiş yaklaşım, yaygın olarak kabul edilen ağrı yönetim kılavuzlarının eksik olması, bilgi, psikolojik ve sosyal faktörler dahil olmak üzere birçok sebepten dolayı karmaşık kabul edilmektedir.
- Ağrı yönetimi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmelidir. Bu, bir ekip içindeki farklı uzmanların iş birliği yapmasını ve hem farmakolojik hem de nonfarmakolojik yöntemleri entegre etmeyi içerir. Yapılan son araştırmalar ve gelişmeler, ağrı yönetimindeki stratejilerin sürekli olarak iyileştirilmesine ve hastalara daha etkili yardım sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. (Pergolizzi Jr, J. V., van de Laar, M., & Langford, R. ,2012)

- Ağrı yönetimi bireysel ihtiyalara, hastanın genel saėlık durumuna ve tedavinin risk ve faydalarına dayanmalıdır. Bu t r bir yaklařım, hastanın yařam kalitesini artırmak ve fiziksel fonksiyonlarını korumak iin etkili bir strateji olabilir. (Groninger, H., & Vijayan, J. ,2014)



Farmakolojik Yöntemler

- **Non-Opioid İlaçlar (Asetaminofen, NSAİİ);** Birçok klinisyen tarafından, tedaviye asetaminofen, steroid olmayan NSAİİ ilaçlar gibi opioid olmayan analjeziklerle başlanması ve hastanın ağrısının şiddeti ve yanıtına bağlı kademeli olarak daha güçlü analjeziklere geçilmesi önerilmektedir. (Groninger, H., & Vijayan, J. ,2014)



- ✓ Asetaminofen, NSAİİ'lara benzer analjezik ve antipiretik etkilere sahiptir ancak spesifik bir anti inflamatuvar etkisi yoktur.
- ✓ Ağrı ve ateşi azaltmak için merkezi sinir sisteminde prostaglandin sentezini inhibe eder.
- ✓ Asetaminofenin güvenli dozu, aminotransferaz düzeylerinde asemptomatik yükselme ve hepatotoksisite riskini azaltmak için günde dört gramı geçmemelidir.
- ✓ Bu, ilacın güvenli kullanımının önemli bir kriteridir.
- ✓ Asetaminofenin düşük maliyeti ve belirgin riskleri, tekrarlayan kullanımının olumlu bir risk-fayda oranına sahip olduğunu gösterir.
- ✓ Asetaminofen ve bir NSAİİ kombinasyonunun, tek başına asetaminofen kullanımına göre daha üstün olduğu bildirilmiştir.
- ✓ Bu durum, belirli şartlar ve hastalıklarda kombinasyon tedavisinin daha etkili olabileceğini göstermektedir, (Prommer, E. E. ,2015, Park, H. J., & Moon, D. E. ,2010)

- Opioid İlaçlar (Morfin, Fentanil, Tramadol vs.) ;

- ✓ Opioid analjezikler, akut ağrıdan kronik ağrıya, kansere bağlı ağrıya ve yaşam sonundaki palyatif bakıma kadar geniş bir yelpazeyi içerir.

- ✓ Bununla birlikte, opioidler kısa vadede çok etkili analjeziklerdir, ancak kanıtlar uzun vadede etkinliğin bazı sınırlamaları olduğunu göstermektedir.

- ✓ Opioid tedavisi alan hastaların düzenli kontrollerinin yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

- ✓ Bu kontrollerde ilaç etkinliği, hastanın ilacı tolere edebilirliği ve doz artırma ihtiyacı gibi konular değerlendirilmelidir. (Sciulli, M. G., Capone, M. L., & Tacconelli, S. ,2005)



- ✓ Opioidlerin uzun süreli kullanımının, özellikle solunum depresyonu, sedasyon, bilişsel ve psikomotor fonksiyon bozukluğu, konstipasyon, bulantı-kusma ve idrar retansiyonu gibi potansiyel riskleri mevcuttur. (Pujol, L. A., & Monti, D. A. ,2007).

Opioid Overdose

Signs of an opioid overdose include:



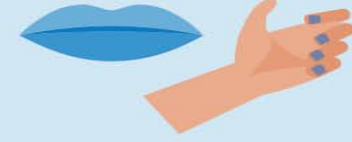
Unresponsiveness or unconsciousness



Pinpoint pupils



Snoring or gurgling sounds coming from mouth



Blue lips or fingernails



Slowed or stopped breathing and heartbeat



Cold or clammy skin



Body is weak or limp



Vomiting

Non-Farmakolojik Yöntemler

- ✓ Farmakolojik olmayan tedaviler, ağrılı hastalar için tedavi modalitesine önemli yardımcılarıdır.
- ✓ Farmakolojik olmayan yöntemler hafif ağrıda bağımsız olarak kullanılabilir. Ek olarak, orta ile şiddetli ağrı için tamamlayıcı bir seçenek olarak farmakolojik tedavi ile birlikte kullanılabilir.
- ✓ Farmakolojik olmayan tedaviler, ilaç veya başka bir etken madde almayı gerektirmeyen, ancak ağrıyı daha tolere edilebilir hale getiren ve hastaya durumu üzerinde kontrol duygusu veren tedaviler olarak tanımlanmaktadır. (He, H. G., Jahja, R., Lee, T. L., & al. ,2010)

Farmakolojik olmayan tedaviler birden fazla kategoriye ayrılır:

- ✓ **Bilişsel davranışsal:** Beyin, beden, zihin ve davranışlar arasındaki etkileşimlere odaklanır. Bu uygulama, zihni başka bir şey hakkında düşünme, hipnoz, imgeleme, gevşeme, dikkati dağıtma, nefes alma tekniklerini içerir.
- ✓ **Duygusal destek:** Duyarlı, ilgili ve anlayışlı yaklaşımlara odaklanır. Bu yaklaşımlar, kaygı veya korkuların azalmasını kolaylaştırır ve zorlukların yönetiminde yardım sağlar.



- ✓ **Rahat bir ortam yaratmak:** Stresin yoğunluğunu/miktarını iyileştirmeye ve mümkün olduğunca rahat bir ortam yaratmaya odaklanır. Örnekler şunları içerir: gürültüyü en aza indirmek, hastanın en sevdiği eşyalarını yanına almasını sağlamak ve oda sıcaklığını korumak.
- ✓ **Fiziksel teknik:** Genellikle eklem, kemik, yumuşak doku, dolaşım ve lenfatik sistem dahil olmak üzere vücudun sistem ve yapılarına odaklanır. Bu teknikler arasında konumlandırma, masaj, sıcak/soğuk uygulama yer alır.
- ✓ **Günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmak:** Bu aktiviteleri gerçekleştirmek için gereken desteğe odaklanır; banyo yapmak, yemek hazırlamak ve yürümek. (Gelinas, C., Arbour, C., Michaud, C., Robar, L., & Cote, J. ,2013, Polkki, T. K., Vehvilainen-Julkunen, K., & Pietila, A. M. ,2001, Gorodzinsky, A. Y., Bernacki, J. M., Davies, W. H., & Zemsky, L. ,2012)

Hemşirelik Yönetimi

- Hemşireler, preoperatif ve postoperatif ağrı yönetimin de hayati bir rol oynamaktadır ve bu nedenle kapsamlı bilgi ve beceriye sahip olmaları hasta güvenliği ve memnuniyeti açısından önemlidir. (Menlah, A., Garti, I., & Amoo, S. A. ,2018).

- Ameliyat sonrası ağrı hastalar arasında yaygın ve yönetimi iyi olmadığı için sorun olmaya devam etmektedir. Dünya genelinde her yıl 230 milyondan fazla cerrahi işlem yapılmakta ve bu sayı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.
- Türkiye’de ameliyat sonrası dönemde ağrı görülme sıklığı %30 ile %97 arasında değişmektedir. (Akpolat, R., Şişman, H., Alptekin, D., Gökçe, E., Gezer, D., & Arslan, S. ,2021, Aslan Eti, F., & Arlı Karadağ, Ş. 2017)

PAIN

- * INDIVIDUAL EXPERIENCE that DEPENDS on MANY FACTORS



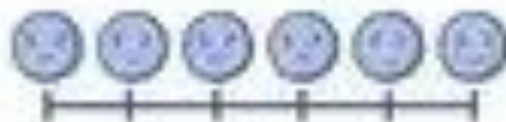
- * CLIENT MIGHT TELL YOU THEY are in PAIN



- * MIGHT NOTICE NONVERBAL SIGNS



- * USE PAIN SCALE & PQRST MNEMONIC



- * PHARMACOLOGIC INTERVENTIONS

- ORDERED PAIN MEDS

- * NON-PHARMACOLOGIC INTERVENTIONS

- REPOSITIONING
- DISTRACTION

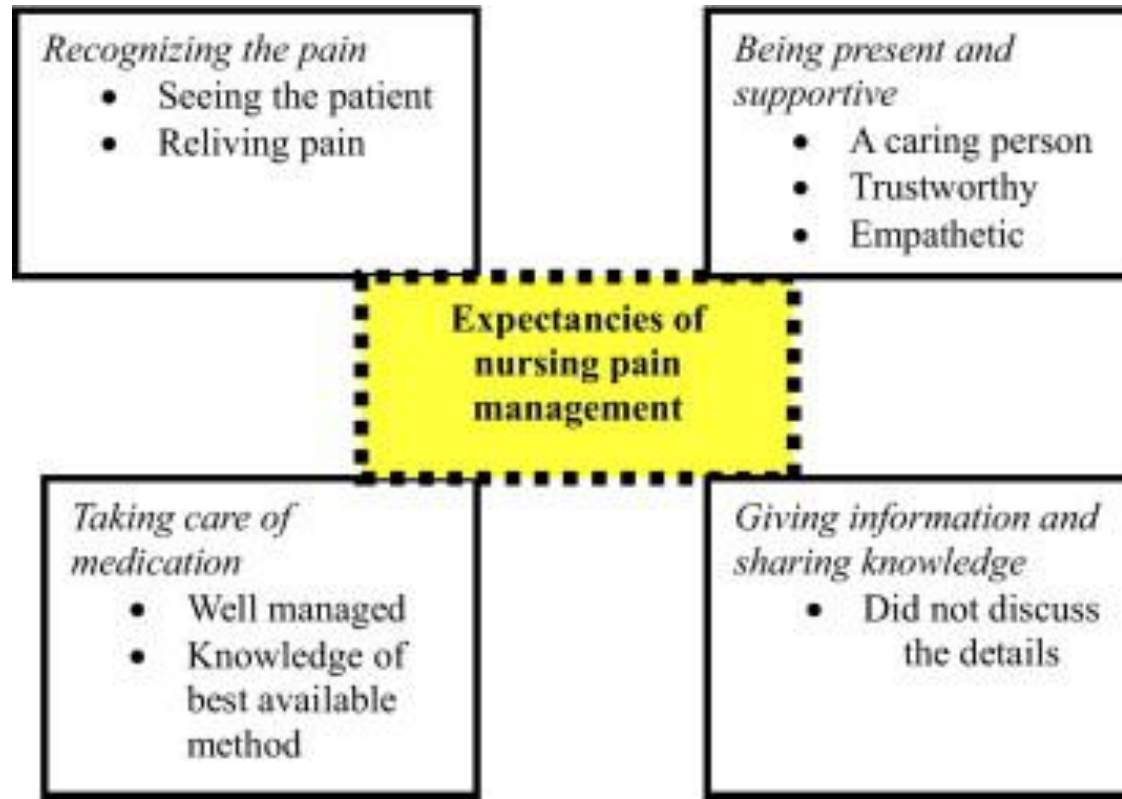
- Ağrının etkili bir biçimde yönetilmesi, hasta konforunu artırmak, iyileşmeyi desteklemek ve komplikasyonları azaltmak açısından önemlidir.
- Ağrının etkili bir şekilde yönetilebilmesi için ağrı derecesinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
- Hemşirelerin ağrıyı yönetme ve değerlendirme becerilerinin arttırılması, etkili ağrı yönetimi için önemlidir.
- Hemşireler, hasta bakımında bu önemli görevi yerine getirerek hastaların ağrılarıyla başa çıkmada kilit rol üstlenmektedirler. (Akpolat, R., Şişman, H., Alptekin, D., Gökçe, E., Gezer, D., & Arslan, S. ,2021)

- Akpolat ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ağrı hemşiresinin sorumluluğunda olmasına rağmen, birçok hemşirenin ağrı tanılması ve tedavisinde yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde başarı sağlanabilmesi için hemşirelerin ağrı değerlendirmesi, tedavisi ve yöntemleri hakkında eğitimler alması ve bu eğitimlerin sürekli güncellenmesinin devamı önerilmektedir. (Akpolat, R., Şişman, H., Alptekin, D., Gökçe, E., Gezer, D., & Arslan, S. ,2021)
- Eder, Sloan ve Todd tarafından yapılan bir çalışmada hastalardaki ağrı insidansının yüksek olması yetersiz değerlendirme ve raporlandırmaya bağlanmaktadır. (Eder, S. C., Sloan, E. P., & Todd, K. ,2003)

- Çelik ve ark.'larının yaptığı araştırmada hemşirelerin ağrı yönetimi konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıklarını göstermiştir. Bu sonuç ile; hasta bakım kalite düzeylerini arttırabilmek için hemşirelerin bilgi ve davranışlarının desteklenmesi, eğitim programlarında ise ağrı konusuna önem verilmesi gerektiği görülmektedir. (Çelik, S., Baş, B. K., & Korkmaz, Z. N. ,2018)

- Ameliyat sonrası ağrının azaltılması ya da ortadan kaldırılması için analjezik uygulanmasının yanı sıra hastanın ağrısının değerlendirilmesi ve ağrı yönetiminin sağlanması için hemşirelerin hastaya bakım sürecinde hemşirelik tanısı oluşturmaları gerekir.
- Başarılı bir ağrı kontrolü için, gerek farmakolojik gerekse farmakolojik olmayan yöntemlerin uygulanmasından önce ağrının çok iyi bir şekilde tanılanması, hemşirelik girişimlerine dahil edilip uygulamalarda bulunulması ve en son elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin ameliyat sonrası ağrı yönetiminde çok önemli bir yeri vardır. (Karadağ Arlı, Ş. ,2017)

- Günümüzde ağrı hemşireliğinin özel dal olarak geliştiği görülmektedir.
- Hemşireler cerrahi hastalarda anamnez alma, ağrıyı değerlendirme ve rapor etme, uygun girişimleri planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirme ile ilgili önemli sorumluluklara sahiptir.



- Ağrı yönetimine ilişkin ilaç uygulamaları; hastanın solunumu, sedasyon düzeyi, ameliyat öncesi genel durumu, opioid toleransı ile ağrı süresi, ağrının sıklığı, ağrının şiddeti, ağrının bölgesi ve ameliyat esnasındaki anestezi uygulamaları düşünülerek bireyselleştirilmiş dozlarda etkili ağrı yönetimini sağlayacak düzeyde olmalıdır.
- İyi bir ağrı değerlendirmesi ve ağrının kontrol altına alınması bireyin rahatlamasına, yaşam kalitesinin yükselmesine, komplikasyonların azalması ve hastanede yatış süresinin kısalmasına yardımcı olur.
- Etkisiz ağrı yönetimi ise yara iyileşmesinde gecikme, derin ven trombozu, pulmoner fonksiyon bozuklukları, yetersiz solunuma bağlı atelektazi, pnömoni, bilişsel bozukluklar, anksiyetede artma, morbidite ve mortalitede artma, taburculukta gecikme ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır ve tedavi edilmeyen ağrının, korku, öfke, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunları oluşturabileceği unutulmaması gereken bir unsurdur. (Oğuz Erdem, G., & Yümnü, H. ,2024)

- Hemşirelerin eğitimi verirken kullanması gereken en etkili yöntemlerden biri "Geri Anlatım" (Teach-Back) yöntemidir.
- Hemşire bilgiyi verir ve ardından hastaya "Lütfen anlattıklarımı kendi cümlelerinizle bana açıklayabilir misiniz?" der. Bu, yanlış anlamaları anında düzeltme şansı tanır. (Tamura-Lis, W. ,2021).

- Ameliyat sabahı verilen eğitim, yüksek stres nedeniyle %80 oranında unutulur. En ideal zaman ameliyattan 1 gün öncedir.
- Broşür, video ve maket kullanımı öğrenmeyi %40 artırır.
- Hastanın yanındaki refakatçinin eğitilmesi, postoperatif dönemde hastanın motivasyonunu ve güvenliğini destekler. (Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. ,2022)

- Araştırma neticesinde; sağlık personeli tarafından hasta bireylere preoperatif dönemde verilen eğitimler sonucunda korku ve endişenin azaldığı, ayrıca iyileşmeye katkı sağladığı gözlenmiştir. Bu sonuçlara dayanarak hasta bireylerin preoperatif döneme ait bilgi gereksinimlerin karşılanması amacıyla verilen eğitim programlarının daha kapsamlı olarak düzenlenmesi, arttırılması ve yaygınlaştırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. (Sakarya Örneği ,2013)

KAYNAKLAR;

1. Adams, S. D. M., Varaei, S., & Jalalinia, F. (2020). Nurses' knowledge and attitude towards postoperative pain management in Ghana. *Pain Research and Management*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/4893707>
2. Akpolat, R., Şişman, H., Alptekin, D., & ark. (2021). Ameliyat sonrası ağrıya yaklaşımların değerlendirilmesi. *Cukurova Medical Journal*, 46(2), 670–676. <https://doi.org/10.17826/cumj.898769>
3. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. (2018). Cerrahi hastalar için belirsizlik ve eğitim.
4. Aslan Eti, F., & Arlı Karadağ, Ş. (2017). Ağrı değerlendirilmesi ve klinik karar verme. F. Aslan Eti (Ed.), *Sağlığın değerlendirilmesi ve klinik karar verme içinde* (ss. 103–133). Akademisyen Tıp Kitabevi.
5. Bastable, S. B. (2022). *Nurse as educator: Principles of teaching and learning for nursing practice* (6. baskı). Jones & Bartlett Learning.
6. Çelik, S., Baş, B. K., Korkmaz, Z. N., & ark. (2018). Hemşirelerin ağrı yönetimi hakkındaki bilgi ve davranışlarının belirlenmesi. *Bakırköy Tıp Dergisi*, 14, 17–23.
7. Eder, S. C., Solan, E. P., & Todd, K. (2003). Documentation of ED patient pain by nurses and physicians. *The American Journal of Emergency Medicine*, 21(4), 253–257.
8. Erden, S., & Şenol Çelik, S. (2013). Torakotomi sonrası ağrı ve analjezi yöntemlerinin kullanılmasında hemşirenin rolü. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2(1-2-3), 11–24.

9. Fornasari, D. (2014). Pain pharmacology: Focus on opioids. *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism*, 11(3), 165–168.
10. Gelinas, C., Arbour, C., Michaud, C., & ark. (2013). Patients and ICU nurses' perspectives of non-pharmacological interventions for pain management. *Nursing in Critical Care*, 18(6), 307–318.
11. Gorodzinsky, A. Y., Bernacki, J. M., Davies, W. H., & ark. (2012). Community parents' use of non-pharmacological techniques for childhood pain management. *Children's Health Care*, 41(1), 1–15.
12. Groninger, H., & Vijayan, J. (2014). Pharmacologic management of pain at the end of life. *American Family Physician*, 90(1), 26–32.
13. He, H. G., Jahja, R., Lee, T. L., & ark. (2010). Nurses' use of non-pharmacological methods in children's postoperative pain management. *Journal of Advanced Nursing*, 66(11), 2398–2409.
14. International Association for the Study of Pain (IASP). (2023, 29 Aralık). Pain terms and definitions. <https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/>
15. Karadağ Arlı, Ş. (2017). Cerrahi bakımda ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik girişimleri. *MCBU-SBED*, 4(3), 1013–1020.
16. Kol, E., Alpar Ecevit, Ş., & Erdoğan, A. (2014). Preoperative education and use of analgesic before onset of pain routinely for postthoracotomy pain control. *Pain Management Nursing*, 15(1), 331–339.
17. Mahran, G. S., Leach, M. J., Abbas, M. S., & ark. (2020). Effect of eye masks on pain and sleep quality in patients undergoing cardiac surgery: A randomized controlled trial. *Critical Care Nurse*, 40.
18. Menlah, A., Garti, I., Amoo, S. A., & ark. (2018). Knowledge, attitudes, and practices of postoperative pain management by nurses. *SAGE Open Nursing*, 4, 1–11.
19. Oğuz Erdem, G., & Yümnü, H. (2024). Ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik yaklaşımları. *ATLJM*, 4(11), 177–183.
20. Özveren, H., Faydalı, S., Gülnar, E., & ark. (2018). Hemşirelerin ağrı değerlendirmesine ilişkin tutum ve uygulamaları. *Journal of Contemporary Medicine*, 8(1), 60–66.

21. Park, H. J., & Moon, D. E. (2010). Pharmacologic management of chronic pain. *The Korean Journal of Pain*, 23(2), 99–108
22. Pergolizzi Jr, J. V., van de Laar, M., Langford, R., & ark. (2012). Tramadol/paracetamol fixed-dose combination in the treatment of moderate to severe pain. *Journal of Pain Research*, 5, 327–346.
23. Polkki, T. K., Vehvilainen-Julkunen, K., & Pietila, A. M. (2001). Nonpharmacological methods in relieving children's postoperative pain. *Journal of Advanced Nursing*, 34(4), 483–492.
24. Prommer, E. E. (2015). Pharmacological management of cancer-related pain. *Cancer Control*, 22(4), 412–425.
25. Pujol, L. A., & Monti, D. A. (2007). Managing cancer pain with nonpharmacologic and complementary therapies. *Journal of the American Osteopathic Association*, 107(7), 15–21.
26. Sakakura, N., Usami, N., Taniguchi, T., & ark. (2010). Assessment of long-term postoperative pain in open thoracotomy patients. *Annals of Thoracic Surgery*, 89(4), 1064–1070.
27. Sakarya Örneği. (2013). Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi.
28. Sciulli, M. G., Capone, M. L., Tacconelli, S., & ark. (2005). The future of traditional nonsteroidal antiinflammatory drugs and cyclooxygenase-2 inhibitors. *Pharmacological Reports*, 57, 66–85.
29. Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15. baskı). Wolters Kluwer.
30. Tamura-Lis, W. (2021). Teach-back for quality education and patient safety. *Nursing Clinics of North America*.
31. Yakupoğlu, S., & Kaya, H. (2025). Ameliyat öncesi anksiyete ve hemşirelik bakımı. *Gevher Nesibe Medical & Health Sciences*, 10(2), 146–156.